

Transcrição do podcast de revisão do Módulo: Direito, Diversidade e Equidade no Sistema Prisional

Caio: Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise profunda de um dos espelhos mais brutais da nossa sociedade: o sistema prisional brasileiro. E o nosso ponto de partida é uma pergunta bem incômoda: para quem esse sistema realmente funciona? Vamos analisar as fontes que recebemos para entender não só a punição, mas como a violência, a saúde e, principalmente, um fio condutor que conecta tudo isso — o racismo estrutural — define quem está atrás das grades e, claro, em que condições.

Vivian: Exato. A proposta é olhar para além dos muros e entender o sistema prisional não como uma ilha, sabe? Mas como o sintoma febril de um corpo social que está doente. As leis, as políticas públicas, elas existem, mas por que a realidade é tão distante do que está no papel? Vamos conectar a superlotação, a falta de saúde, com a história de desigualdade do Brasil para entender a raiz do problema.

Caio: Perfeito. Então vamos começar por essa raiz. As fontes deixam muito claro que a violência no Brasil não é um acidente, é um projeto histórico. A gente fala muito da herança da escravidão, mas às vezes isso soa meio abstrato. Como essa herança se manifesta hoje, assim, no perfil de quem está privado de liberdade?

Vivian: Ela se manifesta de uma forma estatística que é inegável. A grande maioria da população privada de liberdade hoje, olha, é composta por jovens, pessoas negras, com baixa escolaridade. Pessoas que vêm de territórios empobrecidos. É o que chamamos de seletividade penal. O sistema de justiça parece ter um alvo preferencial, e esse alvo é o mesmo grupo social que historicamente foi marginalizado desde a abolição. O aprisionamento em massa, então, não é sobre combater o crime de forma geral; é sobre gerenciar uma parcela específica da população.

Caio: E uma vez que essa pessoa entra no sistema, ela encontra um ambiente que, por si só, já é uma forma de violência. As fontes descrevem uma tríade terrível: confinamento, insalubridade e superlotação. O que isso significa no dia a dia?

Vivian: Significa viver em um ambiente que foi programado para adoecer. Imagina só: celas projetadas para oito pessoas abrigando cinquenta. Sem ventilação adequada, com pouca ou nenhuma luz do sol, com umidade, esgoto a céu aberto. É o cenário perfeito para que doenças que já estavam controladas aqui fora, como a tuberculose e a hanseníase, explodam lá dentro. Uma pessoa privada de liberdade tem, em média, trinta vezes mais chance de contrair tuberculose do que alguém em liberdade. Não é um risco, é quase uma sentença.

Caio: Isso transforma o sistema prisional numa questão de saúde pública que afeta todo mundo, certo? As doenças não ficam contidas pelos muros.

Vivian: Exatamente. E aí que entra um conceito-chave: os determinantes sociais da saúde. A nossa saúde não depende só de genética ou de acesso a hospitais. Depende de onde a gente mora, do que a gente come, se temos acesso à educação, a um trabalho digno. Dentro do sistema prisional, todos esses determinantes são negativos. A ausência

de condições básicas de vida não é um problema individual de cada um; é uma falha estrutural do ambiente, que adoece as pessoas de forma sistemática.

Caio: Diante desse quadro, a solução parece ser a criação de políticas públicas. As fontes mencionam fortalecer o SUS, promover educação, reabilitação... mas me parece um desafio gigantesco implementar isso em um ambiente tão degradado. Como fazer o SUS, por exemplo, realmente funcionar atrás das grades?

Vivian: Esse é o grande nó. A solução não pode ser uma ação isolada. Requer uma articulação que raramente acontece. O sistema de justiça precisa conversar com o de saúde, que precisa conversar com a assistência social e, mais importante, a sociedade civil precisa participar. Organizações que oferecem apoio jurídico, grupos de familiares, entidades de saúde... Sem a pressão e a colaboração deles, as políticas viram apenas portarias, documentos que não mudam a vida de ninguém. O Estado sozinho, historicamente, não deu conta.

Caio: Isso nos leva a uma questão central: a saída da prisão. Se a pessoa sobrevive a esse ambiente, como ela quebra esse ciclo de exclusão e violência? As fontes que a gente analisou apontam a reintegração social como a chave.

Vivian: Sim. E a base para essa reintegração deveria ser a família e a comunidade. Todos os estudos mostram que o fator que mais reduz a reincidência é ter uma rede de apoio afetivo e social esperando do lado de fora. Sem um lugar para voltar, sem alguém que te acolha, o caminho de volta para a ilegalidade se torna muito mais curto e, às vezes, o único possível.

Caio: E a lei prevê isso. Eu sei que existe a Lei de Execução Penal, a LEP. No papel, ela soa muito progressista, falando em caráter educativo e ressocializador da pena.

Vivian: A LEP é, de fato, uma lei avançada. Ela garante uma série de direitos que visam justamente manter ou reconstruir os laços da pessoa com a sociedade. Garante acesso à educação, ao trabalho, à saúde e, o que é fundamental, às visitas familiares. A visita não é um benefício, é um direito essencial para a manutenção dos vínculos, para que a pessoa não seja socialmente aniquilada enquanto cumpre sua pena.

Caio: Certo. Mas agora vamos confrontar a lei com os números que as fontes nos trazem. E aqui a coisa fica chocante. Na educação, por exemplo, qual a porcentagem de pessoas privadas de liberdade que de fato estudam?

Vivian: É um número baixíssimo. Apenas 17,92%. Menos de dois em cada dez têm acesso a alguma atividade educacional que poderia ajudar a construir um futuro diferente. Uma oportunidade que, pela lei, deveria ser para todos.

Caio: E no trabalho a situação é ainda mais complicada. As fontes dizem que só 23,87% trabalham. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da remuneração.

Vivian: Sim, porque mesmo entre os que trabalham, a precariedade é a regra. Os dados são alarmantes: 60,43% dessas pessoas ou não recebem absolutamente nada pelo trabalho, ou ganham menos de três quartos do salário mínimo.

Caio: Espera um pouco, me deixe ver se eu entendi. A lei diz que o trabalho é parte da ressocialização, mas na prática, mais da metade de quem trabalha está numa condição análoga à exploração, recebendo quase nada ou nada? Como isso é legalmente possível?

Vivian: Esse é o argumento oficial: que qualquer trabalho é melhor que o ócio. Mas ele se desfaz quando a própria lei que prevê o trabalho também prevê uma remuneração justa. O objetivo da ressocialização não pode servir de desculpa para violar outros direitos fundamentais, como o direito a ser pago pelo seu esforço. Na prática, vira uma mão de obra barata e cativa, o que desvirtua completamente o propósito da lei.

Caio: É nesse cenário de direitos negados que a saúde se torna ainda mais crucial. As fontes falam muito da PNAISP. O que é exatamente e como ela tenta mudar esse jogo?

Vivian: PNAISP é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. A ideia por trás dela é simples e poderosa: quem está privado de liberdade não perde o direito de ser paciente do SUS. O direito à saúde continua valendo. O desafio é fazer o atendimento chegar lá dentro com a mesma qualidade e humanidade que deveria existir aqui fora. Na prática, isso acontece através das Equipes de Atenção Primária Prisional, as EAPP, que são como os postos de saúde dos bairros, mas adaptadas para operar dentro das unidades.

Caio: E essas equipes conseguem dar conta da demanda?

Vivian: É uma luta constante. Elas são a linha de frente, mas enfrentam a superlotação, a falta de estrutura e, muitas vezes, a desconfiança tanto dos agentes de segurança quanto da própria população carcerária. Mas a existência delas já é um avanço. É o reconhecimento formal de que saúde é um pilar para a dignidade.

Caio: Falando em dignidade, as fontes trazem um recorte de gênero muito forte. As mulheres privadas de liberdade parecem enfrentar um abandono ainda maior.

Vivian: Muito maior. O abandono familiar é drasticamente mais alto para as mulheres. E o próprio sistema não foi pensado para elas. As unidades são adaptadas de modelos masculinos, ignorando necessidades básicas de saúde ginecológica, pré-natal, o cuidado com os filhos. Mas, por outro lado, é também onde vemos iniciativas inspiradoras, como as APACs, o projeto Alvorada, os escritórios sociais. São modelos que buscam criar um apoio comunitário real, com foco no acolhimento e na reintegração, mostrando que outro caminho é possível.

Caio: Essa ideia de que o sistema não foi pensado para as mulheres me leva ao próximo ponto: a diversidade. Tratar todo mundo da mesma forma, em nome de uma suposta igualdade, acaba gerando mais injustiça. O apoio que um homem branco precisa no sistema não é o mesmo que uma mulher trans ou um jovem indígena necessita. O sistema enxerga essas diferenças?

Vivian: A legislação internacional, como as Regras de Nelson Mandela e as Regras de Bangkok, exige que o sistema enxergue. No Brasil, temos resoluções que também determinam isso. Por exemplo, para a população LGBTQIA+, é garantido o direito ao nome social, ao uso de roupas de acordo com a identidade de gênero, o acesso a terapias hormonais. Para pessoas com deficiência, a necessidade de acessibilidade. Para

indígenas e estrangeiros, o direito a intérprete, o respeito às suas práticas culturais e religiosas.

Caio: Mas uma coisa é ter a resolução, outra é a prática. Esses direitos são efetivados?

Vivian: Na maioria das vezes, não. A efetivação depende da sensibilidade e do preparo dos gestores e agentes de cada unidade, e isso varia enormemente. Uma pessoa trans que precisa lutar por meses para ser chamada pelo nome social ou para continuar seu tratamento hormonal, bom, ela está sofrendo uma violência diária, uma negação da sua própria identidade. E isso nos leva a um conceito fundamental para entender a profundidade do problema: a interseccionalidade.

Caio: Que é a ideia de que as opressões se somam, certo?

Vivian: Exatamente. Elas não só se somam, elas se multiplicam. Pense numa mulher indígena que não fala português fluentemente e está privada de liberdade. Ela enfrenta a barreira do gênero num sistema pensado por e para homens; enfrenta a barreira da etnia com seus costumes ignorados; enfrenta a barreira da língua que impede de entender seu próprio processo ou de comunicar uma dor. O sistema não está preparado para lidar com nenhuma dessas vulnerabilidades isoladamente, muito menos com a soma delas. Isso é a interseccionalidade na prática.

Caio: E além de todas essas barreiras, há uma que parece básica, mas que as fontes destacam como crucial: a falta de documentos.

Vivian: Parece simples, mas é devastador. Muitas pessoas entram no sistema sem RG ou CPF, ou perdem os documentos lá dentro. Sem documentação, a pessoa é uma "não cidadã". Não pode receber visitas, não pode se inscrever em cursos, não pode trabalhar formalmente para remição de pena. E quando sai, o pesadelo continua. Sem documentos, não se consegue emprego, não se abre uma conta, não se acessa nenhum programa social. É como impor uma morte cívica, uma forma de garantir que aquela pessoa jamais consiga se reerguer.

Caio: É um ciclo de exclusão que começa muito antes da prisão e continua muito depois. E agora vamos juntar todas essas peças. Falamos de violência histórica, de seletividade penal, de um sistema que adoece e ignora a diversidade. Tudo isso aponta para uma questão central que a gente mencionou no início: o racismo.

Vivian: Sem dúvida. O racismo não é apenas mais um tema, ele é a viga mestra que sustenta toda essa estrutura.

Caio: Então vamos colocar isso em números. A gente falou no começo sobre a herança da escravidão. Se a gente entrasse em um presídio brasileiro agora e separasse dez pessoas, quantas delas seriam negras?

Vivian: Quase sete. A estatística oficial mais recente mostra que 68,2% da população privada de liberdade no Brasil é negra. E esse número não apenas é alto, ele vem crescendo ano após ano. Isso nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável: o sistema prisional é falho em reabilitar ou ele é extremamente eficiente em seu próprio propósito histórico de controlar e neutralizar a população negra?

Caio: Para entender isso, as fontes diferenciam racismo estrutural de racismo institucional. Poderia explicar a diferença?

Vivian: Claro. O racismo estrutural é o modo de organização da sociedade. São as práticas, os hábitos, as políticas que, mesmo sem a intenção individual de discriminar, acabam sempre produzindo desvantagens para a população negra. Já o racismo institucional acontece quando as instituições — um hospital, uma escola, o sistema de justiça — falham em prover um serviço justo e equitativo, reproduzindo essa desigualdade estrutural em suas práticas diárias.

Caio: Como no caso que vimos do José Carlos?

Vivian: Exatamente. O José Carlos passou meses relatando tosse, cansaço extremo e perda de peso. E a resposta que ele recebia da equipe de saúde era que era "frescura", "manha" ou "preguiça" para não trabalhar. O resultado foi um diagnóstico tardio de tuberculose já em estado avançado, com sequelas graves.

Caio: Isso é terrível. Mas alguém poderia ouvir essa história e argumentar: "talvez a equipe estivesse sobrecarregada, foi negligência, não necessariamente racismo". Qual é o elemento que transforma negligência em racismo institucional nesse caso?

Vivian: A diferença está no padrão. A desvalorização da queixa, a presunção da mentira, a desumanização do sofrimento de pacientes negros é um padrão documentado em inúmeros estudos de saúde, dentro e fora do sistema prisional. Quando a palavra de uma pessoa negra tem sistematicamente menos valor, menos crédito do que a de uma pessoa branca, isso não é um erro isolado; é o racismo institucional em ação.

Caio: Então, na prática, como se combate isso?

Vivian: A mudança passa por ações concretas. Primeiro, o preenchimento obrigatório do quesito raça/cor nos prontuários. Sem dados, o problema fica invisível. Segundo, o letramento racial das equipes. É treinar os profissionais para que entendam como o racismo opera, para que reconheçam seus próprios vieses e aprendam a construir uma prática de cuidado ativamente antirracista. Valorizar os saberes, a cultura e a espiritualidade daquela pessoa no processo de cuidado. Para muitas pessoas negras, a conexão com sua religiosidade e ancestralidade é uma fonte poderosa de saúde mental e resiliência. Um cuidado que ignora isso é um cuidado incompleto.

Caio: Recapitulando nossa análise: começamos com a violência histórica, passamos pela falha da reintegração, vimos como a diversidade é ignorada e chegamos à conclusão de que o racismo estrutural é o que conecta todos esses pontos. O sistema prisional parece ser menos sobre justiça e mais sobre a manutenção de uma ordem social desigual.

Vivian: Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final: as leis e as políticas públicas para a garantia da dignidade das pessoas privadas de liberdade existem no papel. O grande desafio, portanto, não é criar mais leis; é questionar as próprias estruturas que tornam essas políticas tão necessárias e, ao mesmo tempo, tão ineficazes. Se o sistema produz consistentemente encarceramento em massa e desigualdade racial,

o que isso revela sobre o nosso conceito de justiça como sociedade? E qual o nosso papel em imaginar e começar a construir algo radicalmente diferente?